INISIATIF KESIHATAN PARU-PARU KEBANGSAAN (LHI)

Rujukan Pantas Saringan LHI

Kriteria kelayakan, LDCT, rujukan ke hospital dan tanggungjawab NaLuRy

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

1. BERISIKO TINGGI (TANPA GEJALA)

Warganegara ≥18 tahun dengan sekurang-kurangnya satu:

- Perokok, bekas perokok, perokok pasif; klien KBM
- Kontak pesakit Tibi; PLHIV
- DM, obesiti, ESRF dalam rawatan dialisis
- Imunosupresan jangka panjang (transplan, biologik, anti-TNF, kanser, steroid)
- Pekerjaan berisiko (anggota kesihatan, asbestos, silika, diesel, pengecat, pengimpal)
- Penghuni tahanan / institusi; Orang Asli, gelandangan, pelarian
- Metadon / penyalahgunaan substans
- Sejarah keluarga penyakit paru-paru atau kanser; pencemaran alam sekitar

2. BERGEJALA

Mana-mana satu tanda amaran:

- Batuk berpanjangan ≥2 minggu
- Batuk berdarah (hemoptysis)
- Sesak nafas / kesukaran bernafas
- Stridor / wheezing
- Jangkitan paru-paru berulang
- Penurunan berat badan tanpa sebab
- Reduced effort tolerance

Pesakit bergejala: spirometri dan CXR / ujian kahak dijalankan **serentak**.

3. KELAYAKAN LDCT

CXR normal + umur 50–70 tahun dan salah satu:

Kategori 1: perokok semasa / bekas perokok berhenti <15 tahun dengan ≥20 pack-years

Kategori 2: pendedahan hazard (perokok pasif, radon, pencemaran, pekerjaan) DAN sejarah penyakit paru-paru (pneumonia, COPD, Tibi) atau kanser

Janji temu LDCT **≤90 hari** (1–3 bulan). Pack-years = (batang sehari ÷ 20) × tahun merokok.

4. VERIFIKASI CXR SEBELUM LDCT

KK dengan AI-CXR (KK Pendang): laporan AI tiada lesi / nodul boleh terus digunakan oleh FMS untuk rujukan LDCT

KK dengan CXR konvensional: hantar salinan filem / DICOM kepada Pakar / PP Radiologi hospital untuk pengesahan “CXR normal” sebelum LDCT dijadualkan

Semua permohonan X-ray, LDCT dan rujukan **wajib bertanda LHI**: cop pada borang fizikal, atau catatan LHI dalam e-HIS / CCMS bagi rujukan atas talian.

5. KRITERIA RUJUKAN KE HOSPITAL / PAKAR (LAMPIRAN E)

Disyaki kanser paru-paru · lesi / nodul / massa mencurigakan pada CXR; Lung-RADS 4A, 4B, 4X atau S; atelektasis segmental / lobar; efusi pleura berulang; perubahan radiologi baharu pada pesakit berisiko tinggi

Asma · diagnosis sukar disahkan; teruk / tidak terkawal; serangan mengancam nyawa; semasa hamil; OCS kerap; komorbid (OSA, ACO); anafilaksis; asma pekerjaan

Tibi · smear-negatif; ekstrapulmonari teruk / disseminated; kes kompleks; kesan sampingan ubat teruk; disyaki / disahkan drug-resistant; kegagalan rawatan; TB dalam PLHIV atau kanak-kanak; tidak stabil

COPD · eksaserbasi akut; ≥2 eksaserbasi setahun walaupun rawatan optimum; respons tidak memuaskan; diagnosis tidak jelas; penilaian LTOT; disyaki ACO

NaLuRy · KLINIK KESIHATAN

PP / FMS: BSLHI_KKM, keputusan CXR, spirometri, FeNO, rujukan. Semak keputusan hospital untuk susulan.

NaLuRy · HOSPITAL

Radiologi / Pakar: keputusan LDCT, laporan biopsi, diagnosis akhir dan pelan rawatan.

PENYELARAS LHI FASILITI

Pastikan data lengkap, jejak kes hingga status akhir, hubungi kes cicir.

SARINGAN SEMULA

Kanser: saringan awal sekali; LDCT Lung-RADS 1–2 diulang setiap 1–2 tahun (FMS). **Asma / COPD:** hanya jika timbul gejala. **Tibi:** ikut Garis Panduan Kawalan Tibi.

HUBUNGI

Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
04-7741156 · ncdjkn.kdh@moh.gov.my